Nefropatía IgA: atacicept (ORIGIN 3) y sibeprenlimab (VISIONARY). ¿Bajar la proteinuria ya demostró proteger el riñón?

Barratt J, et al. Atacicept in IgA Nephropathy — Phase 3 Trial Final Efficacy Analysis. *N Engl J Med*. Publicado en línea el 22 de octubre de 2026. doi:10.1056/NEJMoa2610103 · Rizk DV, et al. Sibeprenlimab in IgA Nephropathy — Final Phase 3 Trial Analysis. *N Engl J Med*. Publicado en línea el 22 de octubre de 2026. doi:10.1056/NEJMoa2609127

Versión 1.0 · Revisado el 24 de octubre de 2026 · Revisión: equipo editorial de Medicina en Resumen, contra el texto completo de ambos artículos

¿CAMBIA LA PRÁCTICA?
Refuerza su uso
Confirma con la función renal lo que la proteinuria anticipó en la aprobación acelerada.

¿ES CONFIABLE EL RESULTADO?
Sólido para la pendiente de TFGe
Doble ciego, preespecificado y consistente en los análisis de sensibilidad.

LO QUE AÚN NO SABEMOS
Diálisis, trasplante y muerte
Dos años de seguimiento y muy pocos eventos duros.

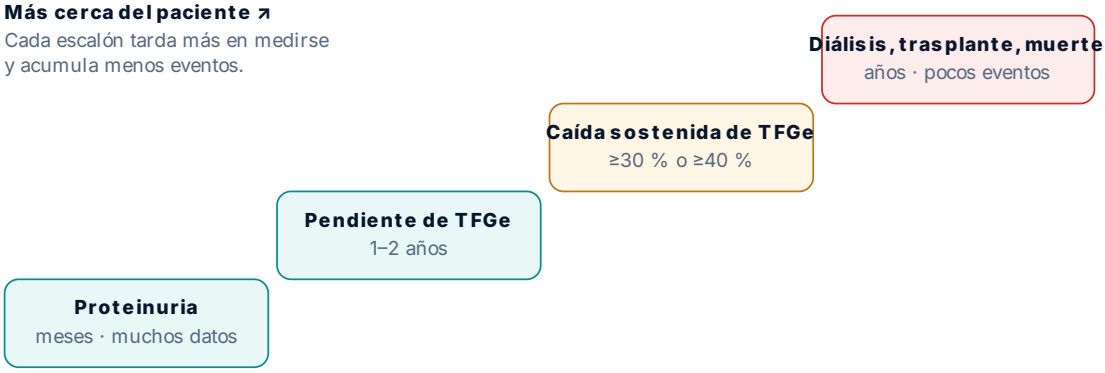
En 30 segundos. Dos fármacos que bloquean APRIL (sibeprenlimab) o APRIL y BAFF (atacicept) habían obtenido aprobación acelerada de la FDA porque redujeron la proteinuria. Los análisis finales, publicados el mismo día, muestran que con ellos la tasa de filtración glomerular estimada (TFGe) prácticamente **dejó de caer** durante dos años, mientras que con placebo cayó unos 4 a 6 mL/min/1.73 m² por año. Es un avance real, pero sigue midiendo la función renal, no todavía la falla renal.

LECCIÓN DE LECTURA CRÍTICA DE ESTA EDICIÓN
Desenlaces sustitutos y la escalera de evidencia: qué tan lejos está cada medida (proteinuria, pendiente de TFGe, caída sostenida de la TFGe, diálisis o muerte) de lo que le importa al paciente, y por qué no se deben comparar razones de riesgo entre ensayos con definiciones distintas.

1 La pregunta clínica (PICO)

	ORIGIN 3 · ATACICEPT	VISIONARY · SIBEPRENLIMAB
Mecanismo	Proteína de fusión TACI-Fc: bloquea BAFF y APRIL	Anticuerpo monoclonal: bloquea solo APRIL
Pacientes	Adultos con IgA por biopsia, en tratamiento de soporte. Mediana de 41 años; TFGe media ~64; 98–99 % con bloqueo del sistema renina-angiotensina y ~61 % con iSGLT2	Adultos con IgA primaria, proteinuria ≥0.75 g/g o ≥1 g/día, TFGe ≥30, bloqueo renina-angiotensina a dosis máxima tolerada; iSGLT2 permitido. Excluidos: síndrome nefrótico y biopsia T2 o C2
Intervención	150 mg SC semanal, autoaplicado en casa (n=214)	400 mg SC cada 4 semanas (n=259)
Comparador	Placebo (n=214)	Placebo (n=251)
Primario (ya publicado)	Proteinuria a 36 semanas: −45.7 % vs −6.8 %	Proteinuria a 9 meses: reducción de 51.2 % ajustada por placebo
Lo que se reporta ahora	Cambio de TFGe a 52 semanas y pendiente anual hasta 104 semanas	Pendiente anual de TFGe en 24 meses

2 La escalera de desenlaces

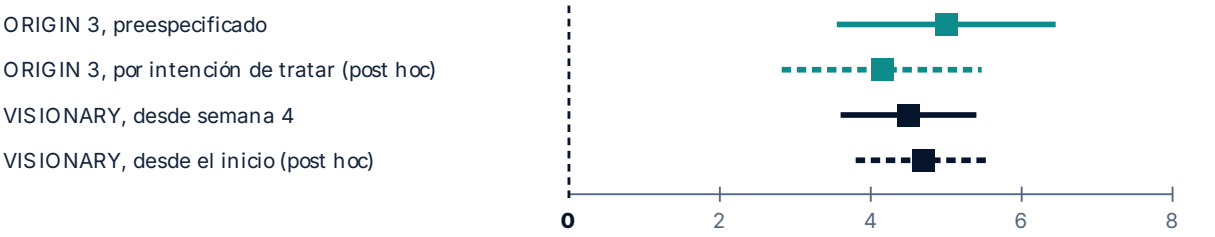


GRÁFICA EDITORIAL Esquema conceptual elaborado por Medicina en Resumen.

ESCALÓN	ORIGIN 3 · ATACICEPT VS PLACEBO	VISIONARY · SIBEPRENLIMAB VS PLACEBO
Proteinuria	−53 % vs −5 % a 52 sem	−61.3 % vs −1.3 % a 24 meses
Cambio de TFGe	−0.11 vs −5.69 a 52 sem Diferencia 5.58 (3.68–7.48)	+1.3 vs −7.9 a 24 meses Diferencia 9.2 (7.1–11.4)
Pendiente anual de TFGe	**−0.60 vs −5.60** Diferencia 5.00 (3.55–6.45)	**+0.3 vs −4.2** Diferencia 4.5 (3.6–5.4)
Compuesto renal	5.1 % vs 17.8 % HR 0.24 (0.12–0.48)	0.4 % vs 11.2 % (1 vs 28 pacientes) HR 0.029 (0.004–0.214)
Diálisis, trasplante o muerte	0 vs 7 pacientes	Terapia de reemplazo renal: 0 vs 5

DATO DEL ARTÍCULO TFGe en mL/min/1.73 m² (pendiente, por año). Valores entre paréntesis: IC 95 %.

Diferencia en la pendiente anual de TFGe (mL/min/1.73 m² por año)



Derecha del 0: el fármaco conserva más función renal por año que e

DATO DEL ARTÍCULO ORIGIN 3: 5.00 (3.55–6.45) y 4.15 (2.82–5.47). VISIONARY: 4.5 (3.6–5.4) y 4.7 (3.8–5.6).
GRÁFICA EDITORIAL Elaborada con esos datos. No es una comparación directa entre fármacos.

3 Cómo leer estos resultados

- **La proteinuria fue suficiente para la aprobación acelerada, no para la certeza.** DATO Ambos fármacos obtuvieron aprobación acelerada de la FDA con la proteinuria del análisis intermedio. INTERPRETACIÓN La aprobación acelerada es condicional: exige confirmar el beneficio con un desenlace más cercano al paciente. Estos artículos son esa confirmación.
- **La pendiente de TFGe es un escalón más arriba, pero sigue siendo sustituta.** INTERPRETACIÓN Una diferencia de ~5 mL/min/1.73 m² por año, sostenida, debería traducirse en años sin diálisis, pero eso es una proyección. La meta que proponen las guías KDIGO 2025 es perder menos de 1 mL/min/1.73 m² por año; las pendientes con atacicept (−0.60) y sibeprenlimab (+0.3) quedaron en ese rango.
- **Lo que pasa al inicio cuenta.** DATO VISIONARY calculó la pendiente desde la semana 4, por incertidumbre sobre el efecto antes de la primera medición; el análisis post hoc desde el inicio dio un resultado similar (4.7). INTERPRETACIÓN Revisa siempre desde cuándo se mide una pendiente: un efecto agudo, favorable o desfavorable, puede quedar fuera.
- **Los eventos duros son muy pocos.** 0 vs 7 y 0 vs 5 van en la misma dirección, pero con tan pocos eventos y solo dos años no permiten estimar con precisión cuánto se reduce la falla renal.

CONCEPTO CLAVE · ¿POR QUÉ NO COMPARAR UN HR DE 0.029 CON UNO DE 0.24?

DATO DEL ARTÍCULO Los compuestos renales no son iguales. ORIGIN 3 contó una caída sostenida de la TFGe **≥30 %** (además de TFGe <15, diálisis, trasplante o muerte); todos sus eventos empezaron por esa caída. VISIONARY exigió una caída **≥40 %** o duplicar la creatinina (además de TFGe <15 o reemplazo renal). El HR de VISIONARY se basa en 1 evento contra 28, y los autores reconocen que el supuesto de riesgos proporcionales fue difícil de evaluar; por eso agregaron una regresión logística (OR 0.026).

INTERPRETACIÓN Un umbral más estricto genera menos eventos; un evento en un grupo produce un HR extremo con un intervalo muy amplio (0.004–0.214). Además, los ensayos difieren en población, ecuación de TFGe (CKD-EPI 2009 con coeficiente de raza vs CKD-EPI 2021) y manejo de los datos faltantes. **Comparar los HR entre ensayos no dice qué fármaco es mejor**: para eso hace falta una comparación directa.

4 El estimando: qué se hizo con lo que no salió según el plan

	ORIGIN 3	VISIONARY
Suspensión del fármaco o rescate sin efecto agudo en la TFGe	Se usan los datos observados (política de tratamiento); los faltantes se imputan como si recibiera placebo (*jump-to-reference*)	Se usan todos los valores disponibles
Medicamentos que alteran la TFGe	Inmunosupresores con efecto agudo: datos posteriores imputados como placebo	Valores posteriores descartados (estrategia hipotética)
Diálisis, trasplante o muerte	Se imputa un valor muy desfavorable	Se imputa la peor TFGe posible
¿Es robusto?	Intención de tratar post hoc: 5.34 a 52 sem y 4.15 en la pendiente	Imputación basada en placebo: 4.4 (3.4–5.3)

INTERPRETACIÓN Cuando el resultado se mantiene con distintas reglas para los datos que "se salen del plan", es más creíble. En ORIGIN 3 el efecto se reduce algo en el análisis por intención de tratar, pero sigue siendo grande.

5 Seguridad

	ATACICEPT VS PLACEBO	SIBEPRENLIMAB VS PLACEBO
Eventos adversos serios	7.0 % vs 15.4 %	8.1 % vs 12.7 %
Infecciones	51.4 % vs 52.3 %	51.4 % vs 51.0 %
Infecciones graves	2.8 % vs 3.7 % (serias o graves)	1.9 % vs 4.0 % (serias)
Reacción en el sitio de inyección	30.4 % vs 7.5 %	—

Inmunoglobulinas	Bajan IgA, IgG e IgM; sin hipogammaglobulinemia clínicamente relevante	IgA −74.8 %, IgG −37.4 %, IgM −77.4 %; 24 pacientes con IgG <400 mg/dL, sin infecciones serias
Anticuerpos contra el fármaco	47.7 %, sin efecto clínico aparente	—
Muertes	0 con atacicept; 1 con placebo	Ninguna

"—" significa que no se reporta en el texto principal del artículo. Dos años de seguridad no descartan infecciones raras ni efectos tardíos de una inmunomodulación crónica.

6 Validez interna, limitaciones y aplicabilidad

ASPECTO	QUÉ REPORTAN LOS ARTÍCULOS	ESTADO
Diseño	Ambos: fase 3, aleatorizados 1:1, doble ciego, controlados con placebo y con orden jerárquico preespecificado de desenlaces.	Confirmado
Multiplicidad	ORIGIN 3: secuencia fija; todos los desenlaces de la jerarquía fueron significativos. VISIONARY: el alfa no usado en el análisis intermedio pasó a la pendiente (bilateral 0.05).	Confirmado
Cambio de plan	ORIGIN 3 adelantó el análisis final de la TFGe de 104 a 52 semanas, alineado con la FDA (19 de mayo de 2026), para pasar antes a los pacientes a atacicept abierto. La pendiente a 104 semanas sí se reporta.	Confirmado; transparente
Abandono desigual	ORIGIN 3: suspendieron el tratamiento 7.0 % con atacicept vs 21.0 % con placebo. VISIONARY: 22 vs 35 pacientes.	Confirmado; lo mitigan los análisis de sensibilidad
Seguimiento	Dos años; extensiones abiertas en curso.	Insuficiente para falla renal
Comparador	Placebo sobre tratamiento de soporte. ORIGIN 3 prohibió iniciar terapias recién aprobadas para IgA durante la fase ciega; ninguno se comparó con budesonida de liberación dirigida, iptacopan u otro fármaco activo.	Confirmado
Población	VISIONARY excluyó síndrome nefrótico, >25 % de semilunas o >50 % de fibrosis (T2/C2). ORIGIN 3 excluyó la recurrencia postrasplante.	Confirmado
Financiamiento	ORIGIN 3: Vera Therapeutics, que participó en la conducción, el análisis y la interpretación. VISIONARY: Otsuka, que participó en el diseño, el análisis, la interpretación y la redacción.	Confirmado; revisar conflictos
Aplicabilidad	Adultos con IgA y proteinuria persistente pese a bloqueo renina-angiotensina (y muchos con iSGLT2). No hay datos en niños, en TFGe <30 (VISIONARY) ni en postrasplante. Disponibilidad y costo fuera de EE. UU. por definir.	Interpretación editorial

7 Dónde encaja con lo previo

TRATAMIENTO	RESULTADO DE FUNCIÓN RENAL A 2 AÑOS, SEGÚN EL ARTÍCULO DE VISIONARY
Budesonida de liberación dirigida (NefIgArd)	Diferencia de 5.1 mL/min/1.73 m² en la TFGe frente a placebo; la función siguió cayendo, más lento
Iptacopan (APPLAUSE-IgAN)	Diferencia en la pendiente de 3.0 mL/min/1.73 m² por año; la función siguió cayendo, más lento
Sibeprenlimab · atacicept	**Pendiente cercana a cero:** la TFGe se estabilizó durante el seguimiento

DATO Cifras tal como las resume la discusión de VISIONARY. **INTERPRETACIÓN** Las poblaciones, la duración y la forma de medir no son idénticas: sirve para ubicar el orden de magnitud, no para elegir entre fármacos.

Pregunta de repaso: VISIONARY reporta un HR de 0.029 para el compuesto renal y ORIGIN 3, de 0.24. ¿Sibeprenlimab protege más el riñón?

Respuesta. No se puede concluir. Los compuestos usan umbrales distintos (caída ≥40 % o doble de creatinina vs caída ≥30 %), las poblaciones y los métodos difieren, y el HR de VISIONARY descansa en un solo evento en el grupo tratado, con un intervalo de 0.004 a 0.214. Lo comparable entre ensayos es más bien la pendiente de TFGe, y ahí ambas diferencias son de magnitud similar (4.5 y 5.0 por año). Para saber cuál es mejor se necesita un ensayo que los compare directamente.

¿Qué aprendí de medicina?

- Bloquear APRIL (con o sin BAFF) **estabilizó la TFGe durante dos años** en IgA con proteinuria persistente pese al tratamiento de soporte.
- Ambos redujeron la proteinuria a la mitad o más y la hematuria se resolvió en ~80 % de quienes la tenían.
- La seguridad a dos años fue similar al placebo, con descenso esperado de inmunoglobulinas y sin aumento de infecciones graves.
- Aún no sabemos cuánto retrasan la diálisis ni cuál es mejor que otro.

¿Qué aprendí de investigación?

- Ubica cada desenlace en la **escalera**: proteinuria → pendiente de TFGe → caída sostenida → falla renal.
- Aprobación acelerada = beneficio **pendiente de confirmar**.
- Revisa **desde cuándo** se mide una pendiente y qué se hizo con los datos tras suspender o rescatar.
- No compares **HR entre ensayos** con compuestos distintos, sobre todo con muy pocos eventos.

8 Referencias

1. Barratt J, Brenner RM, Barbour SJ, et al. Atacicept in IgA nephropathy — phase 3 trial final efficacy analysis (ORIGIN 3). *N Engl J Med*. 2026. doi:10.1056/NEJMoa2610103
2. Rizk DV, Barratt J, Suzuki Y, et al. Sibeprenlimab in IgA nephropathy — final phase 3 trial analysis (VISIONARY). *N Engl J Med*. 2026. doi:10.1056/NEJMoa2609127
3. Lafayette R, Barbour SJ, Brenner RM, et al. A phase 3 trial of atacicept in patients with IgA nephropathy (análisis intermedio). *N Engl J Med*. 2026;394:647-657. doi:10.1056/NEJMoa2510198
4. Perkovic V, Trimarchi H, Tesar V, et al. Sibeprenlimab in IgA nephropathy — interim analysis of a phase 3 trial. *N Engl J Med*. 2026;394:635-646.
5. KDIGO IgAN and IgAV Work Group. KDIGO 2025 clinical practice guideline for the management of immunoglobulin A nephropathy (IgAN) and immunoglobulin A vasculitis (IgAV). *Kidney Int*. 2025;108(4 Suppl):S1-S71.
6. Lafayette R, Kristensen J, Stone A, et al. Efficacy and safety of a targeted-release formulation of budesonide in patients with primary IgA nephropathy (NefIgArd): 2-year results. *Lancet*. 2023;402:859-870.
7. Barratt J, Eren N, Kashihara N, et al. Iptacopan in IgA nephropathy — final 24-month data. *N Engl J Med*. 2026;395:465-477.

Material educativo para profesionales de la salud. Elaborado con apoyo de inteligencia artificial y verificado contra el texto completo de ambos artículos. **DATO DEL ARTÍCULO** = lo que reportan los autores; **INTERPRETACIÓN** = lectura editorial de Medicina en Resumen. No sustituye la lectura de los artículos originales ni el juicio clínico. Las figuras se elaboraron con los datos publicados; no reproducen figuras de los artículos.